

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश श्री श्रीकान्त पौडेल
आदेश

०७७-WO-०६०६

विषय: परमादेश समेत।

महेन्द्र बहादुर कटुवालको छोरा तेहथुम जिल्ला ओखे गा. बि. स. वडा नं. ९ को परिवर्तित छथर गाउँपालिका वडा नं. ५ हाल धनकुटा जिल्ला धरान नगरपालिका निवेदक वडा नं. ७ बसपार्क बस्ने होमियोप्याथिक डा. खगेन्द्र कटुवाल.....१

विरुद्ध

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ...१

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाण्डौ.....१

नेपाल सरकार, आयुर्वेद तथा वैकल्पीक चिकित्सा विभाग, टेकु, काठमाण्डौ.....१

विपक्षी
प्रत्यर्थी

नेपालको संविधानको ४६ र १३३ (२), (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ:-

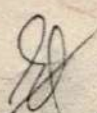
रिट निवेदनको वेवोरा

१. म निवेदक होमियोप्याथिक चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक (BHMS) उपाधि प्राप्त गरी स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता भएको एक जिम्मेवार चिकित्सक एवं नागरिक हुँ। नेपालको संविधान र कानूनले मार्गनिर्देश गरेका जिम्मेवारीहरू पूरा नगरी राज्य र यसका अंगहरूले होमियोप्याथिक चिकित्साको विकास र विस्तारमा चरम उदासिनता देखाएको छ। विपक्षीहरूको कार्य संविधान, ऐन र नियमावलीको प्रावधान विपरीत हुनुका साथै नागरिकको मौलिक हकको समेत बर्खिलाप रहेको छ। राज्यले यस विधिको प्रयोगमा चासो नदिएता नागरिकहरू स्वास्थ्य उपचारमा ठूलो धनराशी खर्च गर्न बाध्य भएका छन् र सस्तो एवं प्रभावकारी उपचार पाउने हकबाट वञ्चित भएको छ। होमियोप्याथिक चिकित्साको अभावति करिब २२५ वर्ष अघिदेखि विकास भएको

नवीन, आधुनिक र विशिष्ट स्वास्थ्य प्रविधि हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वकै दोस्रो ठूलो स्वास्थ्य क्षेत्र ओगटेको लोकप्रिय, सरल र प्रकृतिमैत्री उपचार पद्धति हो। विश्वभर २० करोडभन्दा बढी मानिसले सेवा लिइरहेका छन् र विकसित देशहरूले यसलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीमा समावेश गरेको छ। अमेरिकामा वार्षिक ६० लाख मानिसले यो सेवा लिने गरेको नेशनल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्सको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ। भारतमा यसका लागि छुट्टै आयुष (AYUSH) मन्त्रालय, १९५ भन्दा बढी होमियो मेडिकल कलेज र व्यापक सरकारी अनुसन्धान संयन्त्र क्रियाशील छ।

नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत कोभिड-१९ को समयमा *Arsenicum album-30* लगायतका औषधिहरूलाई रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन उपयोगी भनी *Protocol* जारी गरेको थियो। तर, सरकारले आफ्नै गाइडलाइन कार्यान्वयन नगरी महँगो खोपको मात्र भर परेर यो सस्तो र वैकल्पिक विधिलाई बेवास्ता गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यको हक, धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक र धारा ४४ ले गुणस्तरीय वस्तु एवं सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरेको छ। साथै, धारा ५१ (ज) को देहाय (५) देखि (९) सम्म होमियोप्याथिक लगायतका परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको नीति स्पष्ट उल्लेख छ। यी संवैधानिक व्यवस्थाहरूको विरुद्धमा गएर राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको र महँगो उपचारका लागि बाध्य पारेको देखिन्छ। नेपालमा हाल ललितपुरको हरिहरभवनमा रहेको पशुपति होमियोप्याथिक अस्पतालले ३७,४९३ जनालाई औषधि वितरण गर्दा उत्साहप्रद नतिजा देखिएको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि राज्यले यस क्षेत्रलाई न्यून बजेट दिने र एलोप्याथिक औषधिको विकल्प नै नभए झैं व्यवहार गर्नु न्यायोचित छैन। ऐतिहासिक रूपमा स्पेनिस फ्लु, डेंगु, हैजा र पोलियो जस्ता महामारी नियन्त्रणमा होमियोप्याथीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सफलता प्राप्त गरिसकेको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले समेत सन् २०२० मा *Dr. AKB Sadhavana Mission School of Homeo Pharmacy* को मुद्दामा यसको विकासका लागि परमादेश जारी गरेको नजिर छ।

नेपालमा चिकित्सकहरू दर्ता हुने छुट्टै होमियोप्याथिक मेडिकल काउन्सिल नहुनुले यो क्षेत्र थप उपेक्षित र नियमनविहीन बन्न पुगेको छ। संविधानको धारा ४६



र १३३ (२) र (३) बमोजिम अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएकाले म निवेदक सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु। विपक्षीहरूको उदासिनताका कारण नागरिकहरूले छिटो, सस्तो र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। तसर्थ, हरेक प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका अस्पतालहरूमा होमियोप्याथिक सेवा विस्तार गरी नागरिकको पहुँच सहज बनाउन आवश्यक देखिएकोले होमियोप्याथिक औषधिको उत्पादन, आयात र वितरणलाई व्यवस्थित गरी दक्ष जनशक्ति विकासमा लगानी गर्न राज्यलाई बाध्य पार्नुपर्ने अवस्था छ। नागरिकले आफ्नो इच्छा बमोजिमको उपचार विधि छनौट गर्न पाउने संवैधानिक सुनिश्चितताका लागि विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी हुन अपरिहार्य छ। अतः होमियोप्याथिक विभाग र मेडिकल काउन्सिल गठन गर्न एवं नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने कार्य नगर्न र जुनसुकै तहबाट सेवा लिन पाउने वातावरण निर्माण गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदक डा. खगेन्द्र कटुवालले यस अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन।

यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेश

२. यसमा के कसो भएको हो? निवेदनको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई सो को बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्याद भित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु।

प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा, छिटो कारवाही किनारा गर्नुपर्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिइएको छ। नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।०९।२७ को आदेश।

विपक्षीहरूको लिखित जवाफको वेहोरा

३. नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रत्याभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ जारी गरी



सोमा समाहित कानूनी व्यवस्थाहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा हक हनन भएको भन्नु आधारहीन देखिन्छ। होमियोप्याथी चिकित्सा सेवाको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै सरकारले दशकौं पहिले नै ललितपुरको हरिहरभवनमा पशुपति होमियोप्याथिक अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालन गरिरहेको तथ्यलाई स्वयं निवेदकले स्वीकार गरेको अवस्थामा यस पद्धतिका सम्बन्धमा राज्य उदासिन रहेको भन्नु विरोधाभासपूर्ण छ। नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि कार्य मन्त्रालयबाट नभएको र निवेदकले माग गरेको होमियोप्याथिक मेडिकल काउन्सिल हालको अवस्थामा आवश्यक नभएकाले त्यसलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भविष्यमा स्थापना गर्न सकिने विषयमा मन्त्रालय स्पष्ट छ। मन्त्रालयले क्यान्सर र मृगौला जस्ता जटिल एवं खर्चिला रोगको उपचारका लागि विपन्न नागरिक कोष खडा गरी आर्थिक सहयोग प्रदान गरिरहेको हुँदा नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिएको भन्ने दाबी पूर्वाग्रही र झूटो देखिन्छ। स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा रहेकाले स्वास्थ्य सेवाको विस्तार योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढिरहेको छ। नेपाली जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अधिकतम मात्रामा प्रचलनमा रहेको वर्तमान अवस्थामा संविधानको धारा ३५, ४२ र ४४ विपरीत कार्य भएको भन्नु जानकारीको अभावमा गरिएको तर्क मात्र हो। राज्यले आफ्नो क्षमता र उपलब्ध स्रोत-साधनका आधारमा स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न आयामहरूलाई क्रमशः परिमार्जन गर्दै लगेको सन्दर्भमा कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नीतिगत विषयमा अदालतको हस्तक्षेप आवश्यक देखिँदैन। निवेदकले उठाएका विषयहरूमा मन्त्रालयले नीतिगत र संस्थागत रूपमा सम्बोधन गरिरहेको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने कुनै औचित्य र तार्किक आधार विद्यमान छैन। तसर्थ, मागदाबी तथ्यहीन र वस्तुपरक नभएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ।

४. नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ज) को देहाय (५), (६), (८) र (९) मा उल्लिखित जनस्वास्थ्य सम्बन्धी राज्यका नीतिहरू तथा विशेषतः देहाय (७) बमोजिम होमियोप्याथिक लगायतका परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने

संवैधानिक लक्ष्य अनुरूप वि.सं. २०७४ मा साविकको आयुर्वेद विभागलाई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग मा रूपान्तरण गरी सेवा विस्तार गरिएको छ। यस विभागले वैकल्पिक चिकित्सा महाशाखा अन्तर्गत होमियोप्याथिक चिकित्सकको दरबन्दी सृजना गरी सोको पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन समेत भइसकेको अवस्थामा छ। होमियोप्याथिक विधाको विकासका लागि व्यवसायी तथा सम्बन्धित संघ-संगठनका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयोजन समिति गठन भई संस्थागत कार्यहरू अगाडि बढिरहेका छन्। कोभिड-१९ महामारीको समयमा समेत होमियोप्याथिक चिकित्सकहरूको सुझावमा "Ayurveda and Alternative Medicine Guidelines of Preventive Measures and Management Protocol for Covid-19" जारी गरी यस पद्धतिको उपचारात्मक र निरोधात्मक योगदानलाई राज्यले आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। अतः होमियोप्याथिक सेवालाई भविष्यमा थप विस्तार र सुदृढ गर्दै लैजाने स्पष्ट नीतिगत तथा कार्यान्वयनमुखी सक्रियता कायम रहेकाले विपक्षीद्वारा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, टेकुको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ।

५. नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ भने जनस्वास्थ्य नियमावली, २०७७ को नियम ३ र अनुसूची १ को क्रमसंख्या ९ मा होमियोप्याथिक सेवालाई आयुर्वेद तथा अन्य परम्परागत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएकाले यसलाई महत्व नदिएको भन्ने दाबी अनुचित छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ को बुँदा नं. ६.७ र ६.७.२ मा होमियोप्याथी लगायतका चिकित्सा प्रणालीलाई संघीय संरचना अनुरूप स्थानीय तहसम्म विकास र विस्तार गर्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरी सोही बमोजिम काम कारवाही भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ४३ र ५१ मा निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने संकल्पका साथ होमियोप्याथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको हुँदा यस क्षेत्रमा कार्यपालिकीय सक्रियता छ। राज्यले उपलब्ध स्रोत र साधनको आधारमा क्रमशः नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै जाने विषय कार्यपालिकाको नियमित प्रक्रिया र क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने भएकाले यस नीतिगत विषयमा सम्मानित अदालतबाट रिट आदेश जारी हुनुपर्ने कुनै संवैधानिक वा कानूनी

१४

औचित्य नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छु भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ।

६. यसमा मिति २०८२।१२।२५ गते सम्म बहसनोट पेश गर्नु भनी दुवै पक्षलाई जानकारी दिई नि.सु.का लागि मिति २०८२।१२।२९ मा पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०८२।१०।२५ मा भएको आदेश।
७. नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत नागरिकलाई उचित विधिको छनौट गरी उपचार गर्ने अधिकार रहेकोमा कम खर्चिलो, साइड-इफेक्ट रहित र रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने होमियोप्याथिक विधिलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन। क्यान्सर र मृगौला जस्ता जटिल रोगको उपचारमा राज्यकोषबाट बर्सेनि करोडौं खर्च भइरहेको सन्दर्भमा यो वैकल्पिक पद्धति अपनाउँदा सार्वजनिक खर्चमा उल्लेख्य बचत हुने र WHO ले समेत यसलाई मान्यता दिएको तथ्यगत अवस्था छ। संविधानको धारा ४२(२) र ४४ ले क्रमशः सामाजिक न्याय र गुणस्तरीय सेवाको हक सुनिश्चित गरे तापनि देशभर एउटा मात्र अस्पताल (पशुपति होमियोप्याथिक अस्पताल) सञ्चालनमा रहनुले नागरिकको पहुँचलाई संकुचित बनाएको छ। धारा ५१(ज) र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ मा होमियोप्याथिक पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति भए पनि २०४९ र २०६१ सालमा तयार भएका मेडिकल काउन्सिल सम्बन्धी ऐनका मस्यौदाहरू मन्त्रालयमा थन्किनुले राज्यको उदासिनता पुष्टि हुन्छ। दक्ष जनशक्तिको विकास, औषधी उत्पादन र वितरणको प्रभावकारी नियमनका लागि छुट्टै होमियोप्याथिक चिकित्सा विभाग र मेडिकल काउन्सिल गठन नहुँदा यस क्षेत्रको अनुगमन र गुणस्तर मापनमा गम्भीर चुनौती खडा भएको छ। एचआईभी र क्षयरोग जस्ता आकस्मिक निदान चाहिने बाहेक अन्य स्वास्थ्य समस्यामा यो विधि प्रभावकारी हुने भएकोले यसको तीव्र प्रचार-प्रसार र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न राज्यले लगानी बढाउनु पर्दछ। सरकारले आफ्नै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र कोभिड-१९ को प्रोटोकलमा समेत यसको उपयोगिता स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा यसलाई केवल ओझेलमा राख्नु संवैधानिक मर्म विपरीत देखिन्छ। नागरिकको इच्छा बमोजिम जुनसुकै स्थान र तहबाट निःशुल्क वा सर्वसुलभ सेवा प्राप्त गर्ने हकको सुनिश्चितताका लागि प्रत्येक प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय

अस्पतालहरूमा यो सेवा विस्तार गर्न आवश्यक छ। अतः उल्लेखित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै विभाग, काउन्सिल र अस्पतालहरूको सञ्चाल विकास गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने डा. खगेन्द्र कटुवालको तर्फबाट अधिवक्ता श्री गणेश दाहालले पेश गरेको बहसनोट।

८. वैकल्पिक चिकित्साका लागि आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ कार्यान्वयनमा रहेको र स्वास्थ्य परिषद्हरूलाई एकीकृत छाता ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ। १६ औं योजनाको अवधारणापत्रले समेत सबै स्वास्थ्य उपचार पद्धतिलाई एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने प्राथमिकता राखेको छ। संस्थागत रूपमा सरकारले पशुपति होमियोपेथिक अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ भने साविकको आयुर्वेद विभागलाई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागमा रूपान्तरण गरिएको छ। विभाग अन्तर्गत वैकल्पिक चिकित्सा महाशाखा र होमियोपेथी तथा आम्ची चिकित्सा शाखा क्रियाशील रहेका छन् जहाँ होमियोप्याथिक चिकित्सकको दरबन्दी समेत कायम छ। उक्त शाखाले होमियोपेथी सेवा सुदृढीकरणका लागि कानून, नीति, गुणस्तर र मापदण्ड निर्माणमा सहयोग गर्ने कार्य विवरण बोकेको छ। यसका साथै निजी तथा गैरसरकारी होमियोपेथी अस्पताल र फार्मसी अनुगमन सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति तथा निर्देशिका निर्माण र सञ्चालन स्वीकृतिको कार्य समेत भइरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा भारतले सन् २०१४ मा Ministry of Ayush स्थापना गरी यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ भने त्यहाँ National Commission for Homoeopathy (NCH) Act, 2020 कार्यान्वयनमा छ। भारतमा Central Drugs Standard Control Organization मार्फत होमियोपेथिक औषधिको गुणस्तर नियमन गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले Global Traditional Medicine Strategy 2025-2034 मार्फत वैकल्पिक चिकित्सालाई स्वास्थ्य प्रणालीमा एकीकृत गर्न र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान (evidence base) सुदृढ गर्न जोड दिएको छ। यद्यपि WHO ले होमियोपेथिक औषधिको उत्पादनमा हुने सुरक्षा जोखिम (potential risks) र गुणस्तर नियन्त्रणका चुनौतीहरूबारे सजग रहन समेत सुझाएको छ। नेपाल सरकारले यस विधिलाई निषेध नगरी राज्यको क्षमता,

आवश्यकता र साधन स्रोतको उपलब्धताका आधारमा नीतिगत र संस्थागत संरचनाहरूको क्रमशः विकास गर्दै लगेको छ। राज्यले कुन उपचार प्रणालीलाई कसरी लागू गर्ने र जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार (Executive Discretion) भित्र पर्ने नीतिगत विषय हो। सरकारले संवैधानिक नीति कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाइरहेको र अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा सेवा विस्तार भइरहेको हुँदा निवेदकको कानूनी हकमा आघात पुगेको मात्र मिल्दैन। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको अवलम्बन राज्यका नीतिद्वारा निर्देशित हुने हुँदा यो मौलिक हक जस्तो न्यायिक हस्तक्षेपको मार्गबाट भन्दा पनि कार्यपालिकीय सक्रियताबाट कार्यान्वयन हुने विषय हो। संविधानले अपनाएका राज्यका नीतिहरू राज्यको आर्थिक क्षमता र स्रोतको आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाने सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत रहेको छ। विपक्षी मन्त्रालय तथा विभागले अस्पताल स्थापना, महाशाखा गठन र दरबन्दी सिर्जना गरी होमियोपेथीको प्रवर्द्धनमा कार्य गरिरहेको अवस्थामा रिट जारी हुनुपर्ने विद्यमानता देखिँदैन। तसर्थ, नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामयिक कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरेको र निवेदकको माग क्रमशः सम्बोधन हुने क्रममा रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्री श्रीधार अर्यालले पेश गरेको बहसनोट।

यस अदालतको आदेश

९. नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गणेश दाहालले नेपालको संविधानको धारा ३५, ४२ र ४४ द्वारा प्रत्याभूत स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र उपभोक्ताको मौलिक हक अन्तर्गत नागरिकलाई आफ्नो इच्छा र आवश्यकता अनुसारको प्रभावकारी एवं सस्तो उपचार पद्धति छनौट गर्ने पूर्ण अधिकार रहेकाले राज्यले होमियोप्याथिक विधिलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। संविधानको धारा ५१(ज) र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले यस पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने स्पष्ट लक्ष्य राखेको भएतापनि, देशभर एउटै मात्र अस्पतालमा सेवा सीमित राख्नु र विगतका ऐनका मस्यौदाहरूलाई थन्क्याएर राख्नुले राज्यको चरम उदासिनता र संवैधानिक उत्तरदायित्वको उल्लंघन पुष्टि हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन

38

(WHO) द्वारा मान्यता प्राप्त र कोभिड-१९ को समयमा सरकार स्वयंले समेत प्रभावकारिता स्वीकार गरेको यस विधिलाई ओझेलमा पार्दा नागरिकहरू महँगो एलोप्याथिक उपचारमा निर्भर रहन बाध्य भई राज्यकोषमा समेत ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ। दक्ष जनशक्तिको नियमन, औषधिको गुणस्तर मापन र व्यवस्थित विकासका लागि छुट्टै होमियोप्याथिक चिकित्सा विभाग र मेडिकल काउन्सिल गठन नहुँदा यो क्षेत्र उपेक्षित र नियमनविहीन बनेकाले यसको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि न्यायिक हस्तक्षेप अपरिहार्य देखिन्छ। अतः नागरिकको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न प्रत्येक प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म होमियोप्याथिक सेवा विस्तार गर्ने गरी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो।

१०. विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्रीधर अर्यालले नेपालको संविधानको धारा ३५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्य पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको र दशकौंदेखि पशुपति होमियोप्याथिक अस्पतालमार्फत सेवा प्रवाह भइरहेकाले राज्य यस पद्धतिप्रति उदासिन रहेको भन्नु तथ्यहीन छ। संविधानको धारा ५१ (ज) को लक्ष्य अनुरूप साविकको आयुर्वेद विभागलाई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागमा रूपान्तरण गरी होमियोप्याथिक चिकित्सकको दरबन्दी सिर्जना र पदपूर्तिको प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ र जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ ले होमियोप्याथीलाई वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीको अभिन्न अंग मानी संघीय ढाँचा अनुरूप स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तय गरेको छ। छुट्टै होमियोप्याथिक मेडिकल काउन्सिल गठन वा थप संस्थागत संरचनाहरूको निर्माण राज्यको आवश्यकता, प्राथमिकता र उपलब्ध स्रोत-साधनको आधारमा कार्यपालिकाले गर्ने नीतिगत निर्णय (Executive Discretion) को विषय भएकाले यसमा न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक देखिँदैन। राज्यले आफ्नो आर्थिक क्षमता र साधनको उपलब्धताका आधारमा नीतिगत र संवैधानिक लक्ष्यहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित स्थापित सिद्धान्तसमेत रहेकाले कुनै संवैधानिक

वा कानूनी हकको हनन नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको वहस जिकिरसमेत सुनियो।

११. मिसिल कागजात अध्ययन गर्दा, नेपालको संविधानको धारा ३५, ४२ र ४४ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र उपभोक्ताको मौलिक हक अन्तर्गत नागरिकलाई सस्तो र प्रभावकारी होमियोप्याथिक चिकित्सा पद्धति छनौट गर्ने अधिकार छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको र भारतमा समेत विकसित रहेको यस पद्धतिलाई नेपालको संविधानको धारा ५१(ज) र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ मा संरक्षण गर्ने उल्लेख भए तापनि व्यवहारमा ओझेलमा परेको छ। कोभिड-१९ को समयमा सरकार आफैले यसको उपयोगिता स्वीकार गरेको अवस्थामा पनि देशभर एउटै मात्र अस्पतालमा सेवा सीमित राख्नु र विगतमा तयार भएका ऐनका मस्यौदाहरू कार्यान्वयन गरेको छैन। दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, औषधिको गुणस्तर नियमन र व्यवस्थित विकासका लागि छुट्टै होमियोप्याथिक चिकित्सा विभाग र मेडिकल काउन्सिल गठन नहुँदा यो क्षेत्र उपेक्षित र नियमनविहीन बन्न पुगेको छ। अतः नागरिकको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न प्रत्येक प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म होमियोप्याथिक सेवा विस्तार गर्न तथा आवश्यक संस्थागत संरचना निर्माणका लागि विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी रहेको देखिन्छ।

१२. नेपालको संविधानको धारा ३५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गर्न राज्य पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको र दशकौंदेखि पशुपति होमियोप्याथिक अस्पतालमार्फत सेवा प्रदान गरिरहेकाले राज्य यस पद्धतिप्रति उदासिन रहेको भन्नु निराधार छ। संविधानको धारा ५१ (ज) को लक्ष्य अनुरूप साविकको आयुर्वेद विभागलाई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागमा रूपान्तरण गरी होमियोप्याथिक चिकित्सकको दरबन्दी सिर्जना र पदपूर्तिको प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ र जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ ले होमियोप्याथीलाई वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीको अभिन्न अंग मानी संघीय ढाँचा अनुरूप स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तय गरी सोही बमोजिम कार्य सम्पादन भइरहेको छ। कोभिड-१९ को समयमा विशेष प्रोटोकल जारी गरी यस पद्धतिको उपचारात्मक योगदानलाई राज्यले आधिकारिक

98

रूपमा स्वीकार गरिसकेको र छुट्टै मेडिकल काउन्सिल गठन गर्ने विषय राज्यको आवश्यकता र स्रोत-साधनको उपलब्धताका आधारमा भविष्यमा सम्बोधन हुने नीतिगत विषय हो। राज्यले आफ्नो आर्थिक क्षमता र उपलब्ध स्रोतको आधारमा नीतिहरू क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार (Executive Discretion) को विषय भएको र नागरिकको हक हनन हुने कुनै कार्य नभएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत वेहोराको विपक्षीहरूको पृथक-पृथक तर एउटै आशयको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ।

१३. उपरोक्तानुसारको रिट निवेदन सहितको मिसिल कागजात हेरी दुवै पक्षको तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो:

क. होमियोप्याथिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तारका सम्बन्धमा रहेका विद्यमान संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो रहेको छ?

ख. नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी छनोटको हक (Right to Choice) अन्तर्गत वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको रूपमा होमियोप्याथी सेवालाई स्थानीय तहसम्म पहुँचयोग्य बनाउनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो वा होइन?

ग. होमियोप्याथी विधाको नियमनका लागि स्वायत्त 'होमियोप्याथी चिकित्सा परिषद्' को गठन, छुट्टै बजेट शीर्षकको व्यवस्था र शैक्षिक सुदृढीकरणका लागि निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन?

१४. उल्लिखित प्रश्नहरूको निरोपण गर्नु अघि प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुको सान्दर्भिकता, परिप्रेक्ष्य र गाम्भीर्य सम्बन्धमा केहि चर्चा गर्नु आवश्यक देखिन्छ। तत्सम्बन्धमा विचार गर्दा, होमियोप्याथी चिकित्सा पद्धतिको प्रादुर्भाव अठारौँ शताब्दीको अन्त्यतिर सन् १७९६ मा जर्मनीबाट भएको देखिन्छ। यसका प्रतिपादक प्रख्यात जर्मन चिकित्सक डा. क्रिष्टियन फ्रेडरिक सामुएल ह्यानेमेन (Dr. Samuel Hahnemann) ले तत्कालीन समयमा प्रचलित एलोप्याथिक उपचारका अत्यन्त कष्टकर र शरीरलाई क्षीण बनाउने विधिहरूबाट असन्तुष्ट भई एक सौम्य, सुरक्षित र प्रभावकारी विकल्पको रूपमा यसको अन्वेषण गरेको देखिन्छ। निजले सिन्कोना (Cinchona) को बोक्रामा गरेको परीक्षणबाट "Similia Similibus Curentur" अर्थात् "समानले समानको उपचार गर्छ" भन्ने प्राकृतिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरी स्वस्थ मानव

शरीरमा कृत्रिम रोगका लक्षण उत्पन्न गराउन सक्ने प्राकृतिक पदार्थको अत्यन्त सूक्ष्म मात्राले सोही प्रकृतिको प्राकृतिक रोग निर्मूल पार्न सक्छ^१ भन्ने वैज्ञानिक आधार रहेको देखिन्छ। यसरी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा होमियोप्याथिक चिकित्सा पद्धतिले विशिष्ट ऐतिहासिक र वैज्ञानिक स्थान ओगटेको पाइन्छ।^२ नेपालको आधुनिक स्वास्थ्य इतिहासलाई हेर्दा सत्रौं शताब्दीमा स्थापित सिंहदरबार वैद्यखाना मार्फत आयुर्वेदको विकास भएको छ भने वि.सं. १९४७ मा वीर अस्पतालको स्थापनासँगै एलोप्याथिक प्रणालीको संस्थागत सुरुआत भएको पाइन्छ^३। यसै पृष्ठभूमिमा, वि.सं. २०१० (सन् १९५३) मा राम अघोरी बाबाको पहल र तत्कालीन राजा त्रिभुवनको स्वीकृतिमा ललितपुरको हरिहरभवनमा पशुपति होमियोप्याथिक अस्पतालको स्थापना भएपछि नेपालमा होमियोप्याथीले सरकारी स्तरबाट मान्यता प्राप्त गरेको देखिन्छ।^४

१५. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को तथ्याङ्क अनुसार होमियोप्याथी हाल विश्वकै दोस्रो ठूलो स्वास्थ्य क्षेत्र ओगटेको लोकप्रिय, सरल र प्रकृतिमैत्री उपचार पद्धतिका रूपमा स्थापित भइसकेको पाइन्छ।^५ संसारका १०० भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा कानूनी मान्यता प्राप्त यस पद्धतिबाट विश्वभर २० करोडभन्दा बढी मानिसले सेवा लिइरहेको छन्। विशेष गरी अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स र बेलायत जस्ता विकसित मुलुकहरूले यसलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीमा समावेश गरी उच्च प्राथमिकता दिएको पाइन्छ।^६ औषधीको सूक्ष्म मात्रा (Potentization), नकारात्मक असर (Side-effects) को न्यूनता र आर्थिक सुलभताको विशेषता रहेको पाइन्छ।^७ यसरी विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र सुरक्षित उपचार सुनिश्चित गर्न होमियोप्याथीले आधुनिक चिकित्साको पूरकका रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ।

^१ Appendix C2, accessed April 23, 2026, <https://shisiradhikari.com.np/storage/uploads/library/files/History-of-Homeopathy-in-Nepal.pdf>

^२ homeopathy in Nepal, accessed April 23, 2026, <https://shisiradhikari.com.np/storage/uploads/library/files/History-of-Homeopathy-in-Nepal.pdf>

^३ National Health Policy 2076 राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६_vh40aui.pdf

^४ ऐ.ऐ.

^५ Alternative and Integrative Medicine - Semantic Scholar, accessed April 23, 2026, <https://pdfs.semanticscholar.org/6bd4/bae282d0798bdc2f1c355da6f821c55581ab.pdf>

^६ Globalizing Homeopathic Education: Convergence with WHO-GTM Strategy 2025-2034 - LMHI FRANCE, accessed April 23, 2026, <https://lmhifrance.fr/wp-content/uploads/2025/07/Modernisation-of-Homeopathic-Education-Pg-29-34-Dr.-Raj-K.-Manchanda.pdf>

^७ Alternative and Integrative Medicine - Semantic Scholar, accessed April 23, 2026, <https://pdfs.semanticscholar.org/6bd4/bae282d0798bdc2f1c355da6f821c55581ab.pdf>

१६. दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा भारत होमियोप्याथीको विकास र अनुसन्धानको प्रमुख केन्द्रको रूपमा रहेको छ। यसका लागि छुट्टै AYUSH मन्त्रालय र व्यापक सरकारी अनुसन्धान संयन्त्र क्रियाशील रहेको पाइन्छ।^८ यसै गरी नेपाल होमियोप्याथीको सात दशकभन्दा लामो इतिहास रहेको पाइन्छ। वि.सं. २०१० (सन् १९५३) मा ललितपुरको हरिहरभवनमा स्थापित पशुपति होमियोप्याथिक चिकित्सालय संस्थागत सुरुवातको कोशेढुङ्गा रहेको देखिन्छ। यसरी हालसम्म दशौं हजार नागरिकलाई सेवा प्रदान गरेको समेत देखिन्छ। कानूनी दृष्टिले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले एलोप्याथी र आयुर्वेद जस्तै मान्यता प्राप्त पद्धतिका रूपमा स्वीकार गरेको छ भने वि.सं. २०५५ देखि स्नातक तह (BHMS) को शैक्षिक अभ्यास सुरु भई दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेको पाइन्छ। हाल नेपाल सरकारको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले नियमन र विकासको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको देखिन्छ।

१७. होमियोप्याथीलाई वैकल्पिक तथा पूरक चिकित्सा (Alternative and Complementary Medicine) उपचार पद्धति हो। यसले बाह्य लक्षणलाई मात्र नहेरी व्यक्तिको मानसिक, शारीरिक र भावनात्मक अवस्थाको समग्र विश्लेषण गरी उपचार गर्ने गरेको देखिन्छ। यस पद्धतिले मानव शरीरमा निहित प्राण शक्ति (Vital Force) लाई सुदृढ बनाई रोगलाई जर्दैदेखि हटाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ।^९ नेपाल सरकारले समेत कोभिड-१९ को समयमा यस पद्धतिका औषधिहरूलाई रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन उपयोगी भनी आधिकारिक प्रोटोकल जारी गरेको देखिन्छ।^{१०} खासगरी आधुनिक जीवनशैलीबाट सिर्जित दम, ग्यास्ट्रिक, छालाका कडा रोग र एलर्जी जस्ता दीर्घकालीन समस्यामा यो पद्धति प्रभावकारी र सफल देखिन्छ। साथै भारतको सर्वोच्च अदालतले डा. ए.के.बी. सद्वावना मिसन स्कुल अफ होमियो फार्मेसी विरुद्ध आयुष मन्त्रालय (Civil Appeal No. 4049 of 2020) भएको^{११} मुद्दामा होमियोप्याथिक चिकित्सकहरूलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधीमा मात्र सीमित राख्नु आयुष मन्त्रालयको

^८ Homeopathy - Eyas Landing, accessed April 23, 2026, <https://eyaslanding.com/homeopathy-chicago-therapy/>

^९ Annual Health Report 2079/80 - Government of Nepal, accessed April 23, 2026,

<https://hmis.gov.np/media/51/Annual-Health-Report-207980.pdf>

^{१०} कोभिड-१९ को व्यवस्थापन सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा जारी सूचना | Ministry of Communication and Information Technology, accessed April 23, 2026

^{११} The Institution Of Homeopaths Kerala vs Union Of India on 13 August, 2021, accessed April 23, 2026

११

निर्देशिका विपरीत हुने हुँदा कोभिड-१९ जस्तै देखिने रोगहरूको लक्षण व्यवस्थापन र सहायक उपचारका लागि समेत औषधी सिफारिस गर्न पाउँछन्। होमियोप्याथिक अभ्यास गर्दा आयुष मन्त्रालयको विशिष्ट दिशानिर्देशहरूको पूर्ण पालना गर्दै स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी वा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको अनुमति लिनु अनिवार्य रहेको छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ। अतः जर्मनीबाट सुरु भई भारत हुदै नेपालसम्म विस्तारित वैज्ञानिक पद्धति संवैधानिक रूपमा सुरक्षित र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने भरपर्दो आधार स्तम्भ रहेको देखिन्छ।

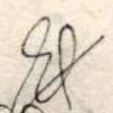
१८. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, होमियोप्याथिक चिकित्सा पद्धतिको विकासका लागि भएका नीतिगत व्यवस्थाहरू मूलतः संवैधानिक प्रावधान र जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐनहरूमा आधारित रहेको देखिन्छ।^{१२} यद्यपि, यी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन पक्षमा जिम्मेवारी बोध गरेको देखिदैन।^{१३} नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ। यस अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको देखिन्छ। संविधानको धारा ५१ (ज) ले राज्यका नीतिहरू निर्धारण गर्दा जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको पाइन्छ। विशेष गरी धारा ५१ (ज) (७) मा "आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी लगायतका चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने" व्यवस्था रहेकोले होमियोप्याथीलाई राज्यको दायित्वभित्र रहेको पाइन्छ।^{१४}
१९. होमियोप्याथीको व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत केही संरचनाहरू क्रियाशील रहेका देखिन्छ, तर ती एलोप्याथी वा आयुर्वेदको तुलनामा अत्यन्तै कमजोर र सीमित रहेको देखिन्छ।^{१५} स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत तीनवटा विभागहरू रहेको छ, जसमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा

^{१२} The Constitution of Nepal - FAOLEX Database | Food and Agriculture Organization of the United Nations, accessed April 23, 2026, <https://faolex.fao.org/docs/pdf/nep155698.pdf>

^{१३} Advancing inclusive and democratic medical pluralism in Nepal - PMC - NIH, accessed April 23, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11625320/>

^{१४} The Constitution of Nepal - FAOLEX Database | Food and Agriculture Organization of the United Nations, accessed April 23, 2026, <https://faolex.fao.org/docs/pdf/nep155698.pdf>

^{१५} Advancing inclusive and democratic medical pluralism in Nepal - PMC - NIH, accessed April 23, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11625320/>



विभागले होमियोप्याथीको प्रशासनिक र प्राविधिक पक्ष हेर्ने गरेको देखिन्छ।^{१६} वि.सं. २०७४ मा साविकको आयुर्वेद विभागलाई पुनर्संरचना गरी वैकल्पिक चिकित्सा शब्द थपिएको समेत देखिन्छ। यस विभाग अन्तर्गत वैकल्पिक चिकित्सा महाशाखा रहेको छ, जसभित्र होमियोप्याथी र आम्ची चिकित्सा शाखा र अर्को प्राकृतिक र अकुपञ्चर चिकित्सा शाखा क्रियाशील रहेको देखिन्छ।^{१७} यद्यपि, विभागको ध्यान मुख्यतया आयुर्वेदमा केन्द्रित हुनुले होमियोप्याथीले पर्याप्त प्राथमिकता पाउन नसकेको देखिन्छ।^{१८} विभागको संगठन संरचनामा होमियोप्याथीका लागि छुट्टै र अधिकार सम्पन्न निकायको अभाव रही यस पद्धतिको योजनाबद्ध विकास र अनुसन्धान भएको समेत देखिदैन।

२०. ललितपुरको हरिहरभवनमा अवस्थित पशुपति होमियोप्याथिक अस्पताल नेपालको एक मात्र सरकारी होमियोप्याथिक अस्पताल रहेको देखिन्छ।^{१९} सन् १९५३ मा ६ शैयाबाट सुरु भएको अस्पताल हालसम्म सेवा प्रदायकको रूपमा रहेको पाइन्छ। सरकारले यसलाई २५ शैयामा स्तरोन्नति गर्ने र आधुनिक सुविधाहरू थप गर्ने योजना अघि सारेको भए तापनि यसको भौतिक र मानवीय संसाधनको अवस्था अझै सुदृढ हुन सकेको देखिदैन। अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक रूपमा हजारौं विरामीहरूले सेवा लिइरहेका देखिन्छ। तर, अस्पताल काठमाडौं उपत्यकामा सीमित हुनुले देशभरका नागरिकहरूले होमियोप्याथी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था समेत देखिदैन।^{२०}
२१. नेपालको संघीय संरचनामा स्वास्थ्य सेवालाई तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्रमा राखेको देखिन्छ। तर, होमियोप्याथीको सवालमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कुनै ठोस संरचनाहरू निर्माण हुन सकेको समेत देखिदैन। बागमती प्रदेश लगायतका अन्य प्रदेशहरूले आफ्नो स्वास्थ्य नीतिमा वैकल्पिक चिकित्सालाई सामेल गरेको देखिन्छ।

^{१६} Department of Ayurveda and Alternative Medicine (DoAA) - Public Health Update, accessed April 23, 2026,

^{१७} Organogram and Reporting Mechanism of Nepalese Health System in Federal Context, accessed April 23, 2026, <https://publichealthupdate.com/organogram-and-reporting-mechanism-of-nepalese-health-system-in-federal-context/>

^{१८} Advancing inclusive and democratic medical pluralism in Nepal - PMC - NIH, accessed April 23, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11625320/>

^{१९} homeopathy in nepal, accessed April 23, 2026, <https://shisiradhihari.com.np/storage/uploads/library/files/History-of-Homeopathy-in-Nepal.pdf>

^{२०} Advancing inclusive and democratic medical pluralism in Nepal - PMC - NIH, accessed April 23, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11625320/>



तर, प्रदेशस्तरमा कुनै पनि होमियोप्याथिक अस्पताल वा विशिष्ट सेवा केन्द्रहरू स्थापना भएका छैन।^{२१} साथै ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला अस्पताल र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू रहेतापनि होमियोप्याथीका लागि कुनै पनि जिल्ला स्तरको सरकारी क्लिनिक वा इकाई छैन।^{२२} यसैगरी स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू निर्माण गर्ने सरकारी कार्यविधि, २०७५ ले खोप, पोषण र सामान्य उपचारमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर, यी केन्द्रहरूमा होमियोप्याथी चिकित्सक वा औषधिको कुनै व्यवस्था गरेको देखिदैन। यसरी होमियोप्याथिक चिकित्सा सेवा मुख्य रूपमा संघीय तहमा मात्र केन्द्रित रहेको पाइन्छ। साथै विभाग अन्तर्गत एउटा शाखाले यस क्षेत्रको प्रशासनिक र सेवामूलक कार्यहरू हेर्ने गरेको देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा भने यस चिकित्सा पद्धतिको उपस्थिति न्यून वा शून्य रहेको पाइन्छ। तथ्याङ्क अनुसार दुवै तहमा हालसम्म कुनै पनि छुट्टै होमियोप्याथिक अस्पताल वा सेवा केन्द्रहरू स्थापना भएका देखिदैन। यद्यपि, प्रदेश तहमा केही आयुर्वेद केन्द्रहरूसँगको समन्वयमा सामान्य सेवाहरू सञ्चालन हुने गरेको देखिन्छ। समग्रमा, होमियोप्याथिक सेवालाई स्थानीय र प्रादेशिक स्तरसम्म विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

२२. राज्यको स्वास्थ्य बजेटमा होमियोप्याथीको हिस्सालाई हेर्दा, यस पद्धतिलाई राज्यले न्यून प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कुल बजेटको तुलनामा होमियोप्याथीका लागि छुट्याइएको रकम नगान्य छ।^{२३} आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को रातो किताब अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि कुल ४,९८,०५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पशुपति होमियोप्याथिक अस्पतालका लागि २२५ लाख रुपैयाँ (०.०४५ प्रतिशत) मात्र छुट्याइएको देखिन्छ।^{२४} प्रस्तुत बजेट अस्पतालको प्रशासनिक खर्च र न्यून औषधि खरिदका लागि पुग्ने देखिन्छ। तर विकास र विस्तारका लागि अपर्याप्त रहेको देखिन्छ। होमियोप्याथीका लागि छुट्टै बजेट कोड नहुनु र यसलाई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको एउटै डालोमा

^{२१} ऐ.ऐ.

^{२२} Department of Ayurveda and Alternative Medicine (DoAA) - Public Health Update, accessed April 23, 2026, <https://publichealthupdate.com/departments-of-ayurveda-and-alternative-medicine-doaa/>

^{२३} Health Sector Budget for Fiscal Year 2023/24 (Red book) - Public Health Update, accessed April 23, 2026, <https://publichealthupdate.com/health-sector-budget-for-fiscal-year-2023-24-red-book/>

^{२४} ऐ. प्रकरण २२

मिसाउनुले यसको वित्तीय स्वायत्ततालाई कमजोर रहको देखिन्छ।^{२५} साथै प्राप्त बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुने भएकाले अनुसन्धान र पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको अभाव रहेको समेत देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो स्वास्थ्य बजेटमा होमियोप्याथीलाई कुनै पनि ठोस कार्यक्रममा समावेश गरेको समेत पाइँदैन।

२३. कुनै पनि चिकित्सा पद्धतिको प्रभावकारिता त्यहाँ कार्यरत दक्ष जनशक्तिमा निर्भर रहेको हुन्छ। होमियोप्याथी जनशक्तिको उत्पादन र व्यवस्थापनको अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको देखिन्छ। होमियोप्याथी चिकित्सकहरूको दर्ता हाल नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (NHPC) मा हुने गरेको देखिन्छ। यस परिषद्ले ल्याब टेक्निसियन, रेडियोलोजिष्ट लगायतका विभिन्न २८ भन्दा बढी विधाका स्वास्थ्यकर्मीहरूको दर्ता गर्ने हुने गरेको देखिन्छ।^{२६} होमियोप्याथी आफैँमा एक स्वतन्त्र र पूर्ण चिकित्सा पद्धति भए तापनि यसको नियमनका लागि छुट्टै होमियोप्याथी चिकित्सा परिषद् नहुनुले यस विधाको प्राज्ञिक र पेशागत मर्यादामा असर पारेको देखिन्छ। NHPC को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हालसम्म करिब १६० जना होमियोप्याथी चिकित्सकहरू दर्ता भएका पाइन्छ। सरकारी सेवामा होमियोप्याथी चिकित्सकहरूको दरबन्दी अत्यन्तै कम रहेको देखिन्छ। हालैका वर्षहरूमा लोक सेवा आयोगले केही पदका लागि विज्ञापन गरेको भए तापनि ती पदहरू देशभरको आवश्यकता पूर्ति गर्न अपर्याप्त रहेको देखिन्छ।

२४. होमियोप्याथी शिक्षाको विकासका लागि सरकारी स्तरबाट कुनै पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेको देखिँदैन।^{२७} विराटनगरमा नेपाल होमियोप्याथिक मेडिकल कलेज निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ। जसले साढे पाँच वर्षको BHMS (Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery) कोर्स अध्यापन गराउँदै आएको देखिन्छ। यसरी अधिकांश होमियोप्याथी चिकित्सकहरू भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूबाट स्नातक र स्नातकोत्तर गरी आएको पाइन्छ। चिकित्सा शिक्षामा सरकारले दिने

^{२५} Budget Analysis of Health Sector - NHSSP, accessed April 23, 2026,
<http://www.nhssp.org.np/Resources/PPFM/Budget%20Analysis%20of%20Health%20Sector%20FY%202020-21.pdf>

^{२६} Nepal Health Professional Council (NHPC) - Public Health Update, accessed April 23, 2026,
<https://publichealthupdate.com/nepal-health-professional-council-nhpc/>

^{२७} Advancing inclusive and democratic medical pluralism in Nepal - PMC - NIH, accessed April 23, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11625320/>

१४

छात्रवृत्तिमा होमियोप्याथीलाई समेटिएको छैन, जसले गर्दा गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीहरू यस विधाको अध्ययनबाट वञ्चित भएको समेत देखिन्छ। तसर्थ: नेपालको संविधानको धारा ३५, धारा ५१(ज)(७) र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले होमियोप्याथीलाई स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अंगका रूपमा मान्यता दिई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिए तापनि व्यवहारमा कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर पाइन्छ। संस्थागत रूपमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग र पशुपति होमियोप्याथिक अस्पताल क्रियाशील रहे तापनि यो सेवा एउटा मात्र सरकारी अस्पतालमा सीमित हुनु र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कुनै ठोस संरचना नहुनुले यसको पहुँचलाई खुम्च्याएको देखिन्छ। राज्यले स्वास्थ्य बजेटमा यस पद्धतिलाई नगण्य प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल स्वास्थ्य बजेटको ०.०४५ प्रतिशत^{२५} मात्र विनियोजन हुनुका साथै दक्ष जनशक्ति र औषधिको गुणस्तर नियमनका लागि छुट्टै स्वायत्त परिषद्को अभाव हुनुले समेत उपेक्षित रहेको देखिन्छ। यसप्रकार संविधानले संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने भनी निर्देश गरेको होमियोप्याथी जस्ता वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरूलाई नीतिगत दस्तावेजमा सीमित नराखी, सोका लागि आवश्यक संरचनागत व्यवस्था, पर्याप्त बजेट विनियोजन र दक्ष जनशक्तिको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको सकारात्मक संवैधानिक दायित्व (positive constitutional obligation) हो। अतः नीतिगत मान्यता भए तापनि पर्याप्त संरचनागत र वित्तीय लगानीको कमीले गर्दा होमियोप्याथी सेवा मूलधारमा समावेश हुन नसकी ओझेलमा परी नागरिकहरू सस्तो र प्रभावकारी वैकल्पिक उपचार पाउने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भइरहेका देखियो।

२५. अव, दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्य सम्बन्धि हक र धारा ५१ (ज) मा रहेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ जारी गरेको देखिन्छ। उक्त ऐनको दफा २ (ख) र (छ) मा स्वास्थ्य सेवाको परिभाषाभित्र आधुनिक चिकित्साका अतिरिक्त आयुर्वेद, होमियोप्याथी, युनानी र प्राकृतिक चिकित्सालाई राखेको पाइन्छ। यसलाई जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ ले थप व्याख्या गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायरामा राखेको देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले पनि आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोप्याथीलाई एकीकृत रूपमा विकास गरी नागरिकको पहुँचमा पुऱ्याउने रणनीति

११

अघि सारेको भए तापनि व्यवहारमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखिन्छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ (थ) ले स्वास्थ्य सेवाको परिभाषा गर्दा आधुनिक चिकित्सा (एलोप्याथी) सँगै होमियोप्याथीलाई पनि समावेश गरेको पाइन्छ।^{२९} यस ऐनको दफा ३ (४)(झ) ले आयुर्वेद तथा अन्य मान्यता प्राप्त वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा व्याख्या गरेको समेत देखिन्छ। जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियम ३ र अनुसूची १ ले होमियोप्याथी सेवालाई सरकारी स्वास्थ्य निकायहरूबाट प्रवाह हुनुपर्ने आधारभूत सेवाको सूचीमा राखेको देखिन्छ। नियमावलीको नियम ४(४) ले होमियोप्याथी अस्पतालहरूले समेत आफ्नै चिकित्सा पद्धति बमोजिम २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।^{३०} राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले चिकित्सा प्रणालीहरूको विविधीकरण र एकीकृत विकासमा प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। नीतिको बुँदा ६.७ मा "आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग तथा होमियोप्याथिकलगायतका चिकित्सा प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा विकास र विस्तार गरिनेछ" भन्ने रणनीति लिइएको छ। त्यस्तै, नेपालको पन्ध्रौँ योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) ले पनि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको पाइन्छ।^{३१}

२६. यसरी नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी छनोटको अधिकार (Right to Choice) र वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न राज्यले सुधारहरू गर्नु पर्ने देखिन्छ। सर्वप्रथम, होमियोप्याथी चिकित्साका लागि छुट्टै स्वायत्त नियमनकारी होमियोप्याथी चिकित्सा परिषद्को स्थापना गरी कानूनी र संरचनागत रिक्तता अन्त्य हुनु पर्ने देखिन्छ। दोस्रो, ७५३ वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा न्यूनतम होमियोप्याथी चिकित्सकको दरबन्दीको व्यवस्था गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई समावेशी बनाउनु पर्ने देखिन्छ। तेस्रो, यस विधाको अनुसन्धान र विकासका लागि

^{२९} The Public Health Service Act, 2075 (2018) - Biological Weapons Convention National Implementation Measures Database, accessed April 23, 2026, https://bwconimplementation.org/sites/default/files/resource/NP_Public-Health-Service-Act-2075_EN.pdf

^{३०} Public Health Service Regulation 2020 - Extranet Systems, accessed April 23, 2026, https://extranet.who.int/ncdccc/Data/NPL_B3_S23_Public%20Health%20Service%20Regulation%202020%20-ENG%20Unofc%20translation-%20clean.pdf

^{३१} Department of Ayurveda and Alternative Medicine (DoAA) - Public Health Update, accessed April 23, 2026, <https://publichealthupdate.com/departement-of-ayurveda-and-alternative-medicine-doaa/>



राष्ट्रिय बजेटमा स्पष्ट बजेट शिर्षक (head) सिर्जना गरी लगानी वृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ। अतः, संविधान र कानूनले मान्यता दिएको भए तापनि संरचनागत र वित्तीय लगानीको अभावमा ओझेलमा परेको होमियोप्याथी पद्धतिलाई राज्यले थप प्राथमिकता दिई भरपर्दो वैकल्पिक उपचार पद्धतिको रूपमा स्थापित गरी स्वास्थ्य सेवाको मूलधारमा प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्नु पर्ने देखिन्छ।

२७. तसर्थ: नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको ग्यारेन्टी गरेको, साथै धारा ५१(ज)(७) ले होमियोप्याथी लगायतका वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको स्पष्ट नीति निर्धारण गरेको देखिन्छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले समेत होमियोप्याथीलाई स्वास्थ्य सेवाको परिभाषाभित्र समेट्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई कानूनी अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ। यस अदालतका विभिन्न न्यायिक आदेशहरूले समेत वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तारलाई राज्यको जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। यसप्रकार नागरिकको स्वास्थ्यको हक उपचार पाउनुमा मात्र सीमित नभई, आफूलाई उपयुक्त र सुलभ लाग्ने मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति (एलोप्याथी, आयुर्वेद वा होमियोप्याथी आदि) छनौट गर्न पाउने अधिकारमा समेत विस्तारित हुन्छ। राज्यले कुनै एक पद्धतिलाई मात्र प्राथमिकता दिई अन्य मान्यता प्राप्त पद्धतिलाई उपेक्षित राख्नु नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी छनौटको अधिकारको उल्लंघन हुन जान्छ। अतः, संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरूको मर्म अनुरूप नागरिकलाई उपचारको विकल्प रोज्न पाउने वातावरण सिर्जना गरी होमियोप्याथी सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व रहेकोमा विवाद देखिदैन।

२८. तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले होमियोप्याथी सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार, छुट्टै होमियोप्याथी मेडिकल काउन्सिलको गठन र उपचार विधि छनौट गर्न पाउने संवैधानिक हक सुनिश्चितताको माग गरेको देखिन्छ। विपक्षीहरूले होमियोप्याथीलाई उपेक्षण नगरेको, पशुपति होमियोप्याथिक अस्पताल र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग मार्फत सेवा दिइरहेको तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले यसलाई आधारभूत सेवामा समेटेको पाइन्छ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (NHPC) बाटै हाललाई नियन्त्रण भइरहेकोले तत्काल नयाँ काउन्सिल आवश्यक

१४

नरहेको र स्रोत-साधनको उपलब्धताका आधारमा सेवा विस्तार गर्ने नीति लिइएको बेहोरा लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। साथै, स्वास्थ्यको हक र वैकल्पिक चिकित्साका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूलाई समेत यस सन्दर्भमा आधार लिइएको देखिन्छ। मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दा (०७७-WO-००३५) मा अदालतले स्वास्थ्यको हकलाई शारीरिक रोगको उपचारमा मात्र सीमित नराखी "समग्र मानसिक र सामाजिक सुस्वास्थ्य" (holistic well-being) को रूपमा व्याख्या गरेको समेत देखिन्छ। अदालतले क्रमिक प्राप्ति (progressive realization) को सिद्धान्तलाई स्वीकार गरे तापनि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई लामो समयसम्म मौलिक हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहर गरेको देखिन्छ। होमियोप्याथीको सन्दर्भमा पनि नागरिकलाई वैकल्पिक उपचार पद्धति रोज्न पाउने हक संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको हकभित्रै अन्तर्निहित रहेको मान्नु पर्ने देखिन्छ।

२९. आयुर्वेद र होमियोप्याथी दुवैलाई वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिका रूपमा हेरिए तापनि राज्यको लगानी, प्राथमिकता र कानूनी संरचनामा ठूलो खाडल रहेको देखिन्छ। आयुर्वेद चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ र आफ्नै छुट्टै परिषद्द्वारा व्यवस्थित रहेको पाइन्छ। होमियोप्याथीलाई जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको सामान्य परिभाषामा मात्र समेटिएको देखिन्छ। यसको नियमन नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले गौण विधाका रूपमा रहेको पाइन्छ। संस्थागत संरचनाको हकमा पनि आयुर्वेद निकै अगाडि रहेको पाइन्छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय लगायत ११ वटा शिक्षण संस्थाहरूबाट आयुर्वेदको जनशक्ति उत्पादन भइरहँदा होमियोप्याथीका लागि एउटा निजी मेडिकल कलेज मात्र सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ। अस्पताल सञ्चालनमा समेत आयुर्वेदका लागि केन्द्रीय नरदेवी अस्पतालदेखि जिल्ला र स्थानीय तहसम्म केन्द्रहरू विस्तारित छन्, तर होमियोप्याथीका लागि ललितपुर हरिहरभवनमा रहेको पशुपति होमियोप्याथी अस्पताल एक मात्र अस्पतालमा खुम्चिएको देखिन्छ। राज्यले आयुर्वेदलाई छुट्टै बजेट र दरबन्दीसहित उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। होमियोप्याथी सीमित बजेट र न्यून दरबन्दीका कारण सरकारी प्राथमिकतामा निकै पछाडि परेको देखिन्छ। यसरी तलुनात्मकरूपमा हेर्दा होमियोप्याथीलाई राज्यले संवैधानिक म्यान्डेट अनुसारको महत्त्व दिएको देखिदैन। एउटै विभाग अन्तर्गत रहेको

दुई पद्धतिबीचको विभेदकारी अवस्थाले होमियोप्याथीको विकास ओझेलमा परेको देखिन्छ।

३०. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को ग्लोबल ट्रेडिसनल मेडिसिन स्ट्राटेजी २०२५-२०३४ ले वैकल्पिक चिकित्सालाई प्रमाणमा आधारित (evidence-based) बनाउन अनुसन्धानमा लगानी बढाउन प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। होमियोप्याथीको प्रभावकारितालाई आधुनिक वैज्ञानिक कसीमा प्रमाणित गर्न क्लिनिकल ट्रायल र डेटा सङ्कलन अनिवार्य रहेको समेत देखिन्छ। पशुपति होमियोप्याथिक अस्पताल र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (NHRC) बीच समन्वय गरी यस्ता अनुसन्धानहरू गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ।^{३२} मोबाइल हेल्थ, टेलिमेडिसिन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को प्रयोग गरी होमियोप्याथी सेवालाई सुदूर ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुऱ्याउन सकिने देखिन्छ। होमियोप्याथिक औषधिहरू प्राकृतिक स्रोत (वनस्पति, खनिज र जनावर) बाट बन्ने हुनाले यी स्रोतहरूको संरक्षण र दिगो उपयोगमा राज्यले ध्यान दिनु पर्ने समेत देखिन्छ। यसरी स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रीकरण र संघीयताको मर्म अनुरूप कुनै पनि चिकित्सा पद्धति केन्द्र वा सहरमा मात्र सीमित नभई, स्थानीय तहका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूसम्म विस्तारित हुनुपर्दछ। पहुँचविहीनताका कारण नागरिकलाई वैकल्पिक उपचारबाट वञ्चित गरिनु सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण मानिने भएकोले वर्तमान संघीय ढाँचा अनुरूप स्वास्थ्य सेवाको अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेपित भइसकेको अवस्थामा होमियोप्याथी सेवाको पहुँचलाई तल्लो तहसम्म पुऱ्याउनु अपरिहार्य रहेको देखियो। बागमती प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०८१ लगायतका प्रादेशिक नीतिहरूले वैकल्पिक चिकित्सालाई प्राथमिकतामा राखे घोषणा गरे तापनि व्यवहारमा यो सेवा अझै पनि स्थानीय तहका नागरिकको पहुँचमा पुग्न सकेको देखिदैन। तसर्थ, ७५३ वटै स्थानीय तहका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा न्यूनतम होमियोप्याथी चिकित्सक वा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी सुनिश्चित गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा (integrated healthcare) को अवधारणालाई मूर्त रूप दिनु पर्ने देखिन्छ। सरकारी क्षेत्रको विस्तारसँगै निजिस्तरमा सञ्चालित होमियोप्याथिक क्लिनिक, अस्पताल र औषधालयहरूको सञ्चालन मापदण्ड तोक्ने,

^{३२} PRIORITY AREA 10: TRADITIONAL MEDICINE - Nepal Health Research Council, accessed April 23, 2026, <https://nhrc.gov.np/wp-content/uploads/2017/04/PRIORITY-AREA-10.pdf>

सोको वैज्ञानिक दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि नियमित अनुगमन र नियमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नु पर्ने देखिन आयो।

३१. होमियोप्याथी विधाको दिगो विकासका लागि शैक्षिक सुदृढीकरण र व्यापक प्रचार-प्रसार अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालमा होमियोप्याथी शिक्षाको जग बलियो बनाउन BHMS (Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery) लगायतका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूलाई राज्यले विशेष प्रोत्साहन, अनुदान र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को Global Traditional Medicine Strategy २०२५-२०३४ ले समेत परम्परागत तथा वैकल्पिक चिकित्साको वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा नेपालका स्थानीय जडीबुटीहरूलाई होमियोप्याथिक औषधिको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न र स्वदेशमै औषधि उत्पादन गर्न फार्मेसीको विकासमा राज्यले प्राविधिक र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ। साथै, होमियोप्याथी पद्धतिको न्यून नकारात्मक असर (side-effects), उपचारको सौम्यता र आर्थिक सुलभताका बारेमा जनसाधारणमा व्याप्त भ्रम चिर्न र सही जानकारी पुऱ्याउनु सञ्चार माध्यमहरूको अधिकतम प्रयोग गरी देशव्यापी जनचेतना र प्रचार-प्रसारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ।
३२. यस क्षेत्रको सबैभन्दा जटिल चुनौतीको रूपमा रहेको नियमनकारी निकायको अभावलाई चिर्न भारतको National Commission for Homoeopathy (NCH) Act, २०२० र अन्य विभिन्न मुलुकमा रहेको रहेको ऐन कानूनको सफल मोडेललाई आधार लिई नेपालमा अनुकूल हुने कानून र स्वायत्त होमियोप्याथी चिकित्सा परिषद् (Homeopathic Medical Council) को गठन गर्न सकिने देखिन्छ। यस्तो परिषद्ले चिकित्सकहरूको शैक्षिक योग्यताको सूक्ष्म जाँच गरी आधिकारिक दर्ता गर्ने, व्यावसायिक मर्यादा र आचारसंहिता (code of ethics) तर्जुमा गर्ने र क्लिनिक तथा औषधिहरूको नियमित निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने देखिन्छ। कुनै पनि चिकित्सकीय लापरवाही वा व्यावसायिक अनुशासनहीनता देखिएमा कारवाही गर्ने अधिकार परिषद्ले सुम्पिएर चिकित्सकहरूको उत्तरदायित्व (accountability) स्थापित गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसप्रकार कुनै पनि चिकित्सा पद्धतिको विकास र जनस्वास्थ्यको

सुरक्षाका लागि सो विधाको छुट्टै र स्वायत्त नियामक निकाय (regulatory body) हुनु अनिवार्य छ। नियमनकारी निकायको अभावमा हुने चिकित्सा अभ्यासले एकातिर पेशागत मर्यादामा आँच पुर्याउँछ भने अर्कोतिर जनस्वास्थ्यमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने हुँदा राज्यले उपयुक्त कानूनी ढाँचा निर्माण गर्नु पर्दछ। साथै होमियोप्याथी उपचार पद्धति मात्र नभई विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि राज्यले दिन सक्ने सबैभन्दा भरपर्दो र सुलभ स्वास्थ्य उपचार पद्धति रहेको पनि देखिन्छ। राज्यले यसलाई कागजी नीतिमा मात्र सीमित नराखी जारी गरेका संविधान र कानूनको मर्म अनुरूप व्यवहारिक बजेट, दक्ष जनशक्ति र कानूनी परिषद्को सुनिश्चितता गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको सशक्त खम्बाको रूपमा विकास गरेमा नागरिकको स्वास्थ्यको संवैधानिक हकले सार्थकता पाउने देखियो।

३३. अतएव: नेपालको संविधान र जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कानूनहरूले होमियोप्याथीलाई महत्वपूर्ण उपचार पद्धतिका रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ।^{३३} नागरिकलाई आफ्नो स्वास्थ्यको संरक्षणका लागि एलोप्याथीको सट्टा वा साथमा होमियोप्याथी रोज्न पाउने हक संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरेको समेत पाइन्छ। राज्यले पशुपति होमियोप्याथी अस्पताल सञ्चालन गरेको र आयुर्वेद विभागमा होमियोप्याथी शाखा राखेको भए तापनि यी प्रयासहरू संविधानको भावना र नागरिकको आवश्यकता अनुसार पर्याप्त रहेको देखिँदैन। बजेटको न्यून विनियोजन, जिल्ला र स्थानीय तहमा संरचनाको अभाव र छुट्टै नियमनकारी परिषद्को अभावले यस क्षेत्रलाई उपेक्षित बनाएको देखिन्छ। यद्यपि, राज्यले आफ्नो लिखित जवाफमा होमियोप्याथी पद्धतिको विकासका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको र उपलब्ध स्रोत-साधनको आधारमा सेवा विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको देखिन्छ। कार्यपालिकाले नीतिगत रूपमा होमियोप्याथीको महत्त्वलाई स्वीकार गरिसकेको र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा अदालतले तत्कालै हस्तक्षेप गरी परमादेश जारी गर्न उपयुक्त देखिँदैन। राज्यका अङ्गहरूले आफ्नो सीमित आर्थिक स्रोत र प्राथमिकताका आधारमा स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न विधाहरूको सन्तुलित विकास गर्ने कार्य गरिरहेको अवस्थामा

^{३३} The Constitution of Nepal - FAOLEX Database | Food and Agriculture Organization of the United Nations, accessed April 23, 2026, <https://faolex.fao.org/docs/pdf/nep155698.pdf>

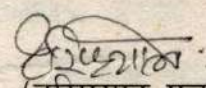


निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन। तर, नागरिकको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन र राज्यको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नका प्रत्यर्थीहरूका लागि देहायका निर्देशात्मक आदेशहरू जारी हुने देखिन आयो:-

- क. होमियोप्याथी चिकित्सा पद्धतिको दर्ता, निरीक्षण, अनुगमन र चिकित्सकहरूको आचारसंहिता निर्माणका लागि आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् जस्तै शक्तिशाली र स्वायत्त होमियोप्याथी चिकित्सा परिषद् वा उपयुक्त नियामक निकाय गठन गर्न आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्नु।
- ख. पशुपति होमियोप्याथिक अस्पताललाई केन्द्रीय विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्दै सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक-एकवटा प्रादेशिक होमियोप्याथिक अस्पताल र ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा होमियोप्याथी इकाई वा सम्पर्क व्यक्ति रहने गरी संरचनात्मक व्यवस्था गर्नु।
- ग. स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुल बजेटमा होमियोप्याथीका लागि छुट्टै शीर्षक (budget head) कायम गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने तथा स्थानीय तहका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा समेत होमियोप्याथी चिकित्सक र औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आवश्यक दरबन्दी सृजना गर्नु।
- घ. नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा होमियोप्याथी शिक्षाको अध्ययन अध्यापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सरकारी छात्रवृत्तिमा होमियोप्याथीलाई समावेश गर्ने र यस पद्धतिको प्रचारप्रसारमा सहयोग पुऱ्याउनु।
- ङ. नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (NHRC) मार्फत होमियोप्याथी औषधिको प्रभावकारिता र नेपाली जडिबुटीहरूको होमियोप्याथिक प्रयोगका बारेमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र क्लिनिकल ट्रायलहरू सञ्चालन गर्ने गराउनु।
- च. एलोप्याथी र होमियोप्याथीबीचको समन्वय बढाउन एकीकृत चिकित्सा (integrative medicine) को अवधारणा अनुसार अस्पतालहरूमा दुवै पद्धतिका चिकित्सकहरूले सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु।
३४. तसर्थ, माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट नेपालको संविधान र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले होमियोप्याथीलाई स्वास्थ्यको मौलिक हक र आधारभूत सेवाभित्र समेटेको भए तापनि न्यून बजेट, संरचनागत अभाव र छुट्टै नियमनकारी परिषद्को

१४

अनुपलब्धताका कारण यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ। विपक्षीहरूले उपलब्ध स्रोत-साधनका आधारमा क्रमिक सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको र कार्यपालिकाले नीतिगत रूपमा यसको महत्त्व स्वीकार गरेकोले माग बमोजिमको परमादेश जारी गर्नु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। तथापि, नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक र उपचारको विधि छनोट गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पशुपति होमियोप्याथिक अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने, सातै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सेवाको संरचनात्मक विस्तार गर्ने तथा पर्याप्त बजेट शीर्षक र जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक सुधार गर्न, होमियोप्याथी चिकित्सा विधाको प्रभावकारी नियमन, चिकित्सकहरूको आचारसंहिता निर्माण र व्यावसायिक उत्तरदायित्व स्थापित गर्न स्वायत्त होमियोप्याथी चिकित्सा परिषद् वा उपयुक्त नियामक निकाय गठनका लागि आवश्यक कानुनी एवं प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउनु, होमियोप्याथी शिक्षाको सुदृढीकरण र यस पद्धतिको योजनाबद्ध विकास मार्फत नागरिकलाई भरपर्दो वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न विपक्षीहरूका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ। प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई निर्देशानात्मक आदेशको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १२७ को उपनियम ४ बमोजिम फैसला कार्यान्वयन निर्देशानालयलाई फैसलाको प्रतिलिपि समेत पठाई दिनु, सरोकारवालाहरूले नक्कल मागे कानूनको रित पुर्‍याई नक्कल दिनु। प्रस्तुत आदेशलाई यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु। रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनु।


(हरिप्रसाद फुयाल)
न्यायाधीश

उक्त आदेशमा सहमत छु।


(श्रीकान्त पौडेल)
न्यायाधीश

इजलास अधिकृत (उपसचिव): महेश्वर अर्याल

कम्प्युटर अपरेटर : रामशरण तिमिल्सिना

इति सम्बत् २०८३ वैशाख महिना ४ गते रोज ६ शुभम्